

2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회 D+1 결과 리뷰

Leadership Brief | 2026.10.01

항목	내용
회의	2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회
회의일	2026년 9월 30일(수)
보고일	2026년 10월 1일(목)
보고 대상	보험약가 · Market Access Leadership
공식 확인	건강보험심사평가원 「2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」
핵심 결과	반플리타·민주비 소포성 림프종·셈블릭스 1차 CML 확대는 급여기준 설정, 민주비 DLBCL·카빅티 다발골수종은 급여기준 미설정

1. Executive Snapshot

한 줄 결론: 이번 암질심은 AML·소포성 림프종·CML 1차 치료에서 급여기준 설정 또는 확대가 확인된 반면, DLBCL과 다발골수종 CAR-T는 급여기준 미설정으로 갈랐다. 동일 제품도 적응증·치료 위치·병용요법별로 결과가 분리된 만큼, 향후 접근성 판단은 제품 단위가 아니라 환자군과 regimen 단위로 관리해야 한다.

3대 leadership implication

Implication	Leadership take-away
혈액암의 치료 위치가 핵심 access gate로 작동	반플리타의 신규 AML 1차 치료, 셈블릭스의 CML 1차 확대처럼 표준치료 내 위치와 환자 선별을 급여기준 문구로 구체화하는 흐름이 이어졌다.
동일 제품의 적응증별 split decision	민주비는 소포성 림프종은 설정됐지만 DLBCL은 미설정됐다. 제품의 전체 가치보다 적응증별 근거, 병용 파트너, 이전 치료와 이식 적합성이 결과를 좌우한다.
미충족 수요만으로는 기준 설정이 보장되지 않음	카빅티는 재발·불응성 다발골수종에서 미설정됐다. 중증도와 치료 공백 외에 비교경로, 대상 환자 정의, 재정 영향 및 실행 가능한 기준문구가 함께 요구된다.

2. 공식 심의 결과: compact result table

구분	품목·성분	회사	대상/신청 요지	공식 심의 결과
요양급여 결정신청	반플리타정 — 퀴자티닙염산염	한국다이하이피산코	FLT3-ITD 변이 양성 신규 진단 AML 성인의 유도·공고요법 병용 및 공고 후 유지요법	급여기준 설정
요양급여 결정신청	민주비주 — 타파시타말	한독	재발·불응성 소포성 림프종 Grade 1~3a에서 레날리도마이드·리톡시말 병용	급여기준 설정
요양급여 결정신청	민주비주 — 타파시타말	한독	ASCT 부적합 재발·불응성 DLBCL에서 레날리도마이드 병용 후 단독요법	급여기준 미설정
급여기준 확대	셈블릭스정 — 애시미닙염산염	한국노바티스	새로 진단된 Ph+ CML 만성기 성인 환자의 1차 치료	급여기준 설정
요양급여 결정신청	카빅티주 — 실타캅타젠오트류셀	한국안센	1차 이상 치료 및 레날리도마이드 불응 이후 재발·불응성 다발골수종	급여기준 미설정

3. 시장·정책 시사점

첫째, 이번 결과는 혈액암 access가 치료 단계별로 세분화되고 있음을 보여준다. 반플리타와 셈블릭스는 각각 신규 AML 1차 치료와 CML 1차 치료라는 명확한 위치에서 기준이 설정됐다. 단순한 허가 범위보다 실제 표준치료 안에서의 사용 위치, 이전 치료 여부, 유지요법 범위가 payer 판단의 중심이 된다.

둘째, 민주비의 결과는 동일 성분의 적응증별 분리 평가를 재확인한다. 소포성 림프종과 DLBCL은 질환 생물학, 치료경로, 병용·단독요법, 이식 적합성 조건이 다르다. 따라서 회사와 payer가 공유하는 value story도 제품 수준이 아니라 적응증별 evidence package로 구성되어야 한다.

셋째, 카빅티 미설정은 고가 세포치료제의 실행 가능성 gate를 부각한다. CAR-T 영역에서는 미충족 수요와 임상효과뿐 아니라 대상 환자 선별, 이전 치료 조건, 투여 인프라, 재정 영향 및 실제 급여기준 운영 가능성을 동시에 설명해야 한다. 이번 결과는 후속 재신청 시 보완 논리가 단순 효능 추가를 넘어야 함을 시사한다.

4. MSD 영향: direct issue는 없지만, read-through는 세 가지

4.1 Keytruda regimen·line별 접근성 논리 강화

이번 회의에 MSD 직접 품목은 없었다. 다만 민주비의 split decision은 키트루다 병용·단독 전략에서도 질환, biomarker, line of therapy, 병용 파트너별로 별도 급여기준이 설정될 수 있음을 재확인한다. 하나의 브랜드 narrative보다 적응증별 comparator, 대상 환자, 치료기간과 재정관리 논리를 분리해 준비해야 한다.

4.2 1차 치료 확대는 장기 재정관리 설명이 필요

셈블릭스의 CML 1차 확대와 반플리타의 AML 1차 설정은 초기 치료 환자군으로의 접근성 확대가 장기 투여·유지요법·환자 수 관리와 연결된다는 점을 보여준다. MSD의 조기 암 및 perioperative 전략에서도 eligible population, 치료기간, 중단 기준과 예산영향을 동일한 구조로 연결할 필요가 있다.

4.3 혈액암·세포치료제 dossier의 실행 가능성 점검

카빅티 미설정은 중증 질환과 높은 unmet need가 기준 설정을 자동으로 보장하지 않는다는 사례다. 향후 유사 영역의 제출자료는 임상효과뿐 아니라 국내 치료경로, 환자 선별의 재현성, 투여 인프라와 재정영향 관리 방안을 한 묶음으로 제시해야 한다.

5. Next watchlist

후보/영역	현재 의미	관찰 포인트
반플리타	AML 1차 급여기준 설정	약평위 결정신청, 평가금액·가격협상 및 최종 고시 일정
셈블릭스	CML 1차 급여기준 확대 설정	기존 급여범위와 신규 1차 대상군의 세부 기준, 장기 투여 관리
민주비 DLBCL	급여기준 미설정	미설정 사유 보완, 재신청 여부와 소포성 림프종 설정 범위의 실제 적용
카빅티	다발골수종 급여기준 미설정	환자 선별·치료라인·세포치료 인프라 및 보완자료 방향
10차 약평위	다음 2026년 10월 1일 차수	암질심 설정 품목의 결정신청 전환 및 기존 급여기준 확대 안건

6. Leadership actions

1. Regimen-level tracker 운영: 암질심 결과를 제품명 하나로 저장하지 말고 적응증, 병용 파트너, 치료라인, biomarker, 이전 치료 조건별 row로 관리한다.

2. 혈액암 dossier checklist 보강: 1차 치료 및 유지요법 확대 시 환자 수, 치료기간, 중단 기준, comparator와 장기 재정영향을 하나의 evidence chain으로 점검한다.
3. Split decision 대응: 동일 제품의 설정·미설정 적응증을 분리해 후속 약평위·재신청·고시 모니터링을 수행하고, 미설정 적응증의 보완자료는 설정 적응증의 근거로 대체하지 않는다.
4. Keytruda read-through 검토: 병용요법별 급여기준과 치료 위치를 기준으로 기존·확대 적응증의 access scenario와 BIA 가정을 재점검한다.

7. 출처 및 해석 범위

본 brief의 공식 사실은 건강보험심사평가원이 공개한 「2026년 제8차 중증(암)질환심의위원회 심의결과 공개」의 회의명, 회의일, 품목명, 성분, 회사명, 대상 질환 및 심의 결과 문구에 근거한다. 공식 보도자료는 2026년 9월 30일 공개됐으며, 세부 급여 적용 여부·시행일·약가와 최종 기준은 후속 약평위, 약가협상 및 보건복지부 고시 절차에 따라 확정된다.

시장·정책 시사점과 MSD 영향은 공개된 공식 결과를 바탕으로 한 Market Access 해석이다. 비공개 환급률, 회사별 내부가격, 최종 약가 또는 특정 품목의 등재일은 추정하지 않는다.